PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOÇÕES DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 16 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

16.1 Nutrientes

Macronutrientes (fornecem energia):

Nutriente	Calorias por grama	Função	Fontes
Carboidratos	**4 kcal**	Principal fonte de energia	Arroz, pães, massas, tubérculos, frutas
Proteínas	**4 kcal**	Construção e reparação de tecidos (plástica), enzimas, anticorpos	Carnes, ovos, leite, leguminosas (feijão, lentilha)
Lipídios (gorduras)	**9 kcal**	Reserva de energia, absorção de vitaminas lipossolúveis, hormônios	Óleos, manteiga, castanhas, carnes gordas

Micronutrientes (vitaminas e minerais – função reguladora): vitaminas **lipossolúveis** (**A, D, E, K**) e **hidrossolúveis** (complexo B e C).

Micronutriente	Deficiência	Fontes
Vitamina A	Cegueira noturna, xeroftalmia	Fígado, cenoura, abóbora, manga
Vitamina D	Raquitismo (criança), osteomalácia (adulto)	Exposição solar, peixes, ovos
Vitamina K	Distúrbios de coagulação	Verduras verde-escuras
Vitamina C	Escorbuto (sangramento gengival)	Frutas cítricas, acerola, goiaba
Vitamina B12 e ácido fólico	Anemia megaloblástica; ácido fólico – defeitos do tubo neural	B12: carnes; folato: folhas verdes, feijão
Vitamina B1 (tiamina)	Beribéri; encefalopatia de Wernicke (etilistas)	Cereais integrais, carne de porco
Ferro	**Anemia ferropriva** (a mais comum)	Carnes vermelhas, fígado, feijão (melhor absorvido com vitamina C)
Iodo	Bócio, hipotireoidismo	**Sal iodado**, frutos do mar
Cálcio	Osteoporose	Leite e derivados

Fibras alimentares regulam o trânsito intestinal e ajudam no controle da glicemia e do colesterol. A água é essencial (cerca de 30 a 35 mL/kg/dia no adulto saudável).

16.2 Guia Alimentar para a População Brasileira (2014)

Classifica os alimentos pelo **grau de processamento**:

- **In natura ou minimamente processados:** devem ser a **base da alimentação** (frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, ovos, leite, carnes frescas).
- **Ingredientes culinários processados:** óleos, gorduras, sal e açúcar – usar em **pequenas quantidades**.
- **Processados:** conservas, queijos, pães feitos com farinha, sal e fermento – **limitar** o consumo.
- **Ultraprocessados:** refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, embutidos, macarrão instantâneo – **evitar**.

A "regra de ouro" é: **prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados**.

16.3 Dietas hospitalares

Dieta	Consistência / características	Indicação
Geral (livre)	Sem restrições	Pacientes sem necessidade de modificação

Branda	Alimentos abrandados pela cocção, sem frituras	Transição para a dieta geral, dificuldade leve de mastigação, pós-operatório tardio
Pastosa	Alimentos amassados, em purê	Dificuldade de mastigação e deglutição, pós-operatório de cabeça e pescoço
Líquida-pastosa (semilíquida)	Líquidos e alimentos de consistência cremosa	Transição de líquida para pastosa
Líquida completa	Todos os alimentos líquidos (leite, sucos, sopas liquidificadas)	Pós-operatório, preparo de exames
Líquida restrita (de prova / clara)	Água, chás, caldos coados, gelatina, sucos coados sem resíduos	Primeira dieta após cirurgia, preparo de colonoscopia; deixa poucos resíduos
Zero (jejum)	Nada por via oral	Pré-operatório, preparo de exames, risco de broncoaspiração

Dietas especiais: hipossódica (HAS, ICC, cirrose, DRC), para diabéticos (controle de carboidratos simples e fracionamento – 5 a 6 refeições), hipolipídica (dislipidemia, pancreatite), hiperproteica (queimados, desnutridos, cicatrização), hipoproteica (DRC não dialítica, encefalopatia hepática), rica em fibras (constipação), sem glúten (doença celíaca), sem lactose (intolerância à lactose).

16.4 Nutrição enteral e parenteral

Nutrição enteral (NE): administração de dieta pelo trato gastrintestinal, por sonda (nasogástrica, nasoenteral, gastrostomia, jejunostomia), quando o paciente **não pode ou não deve se alimentar pela boca, mas tem o intestino funcionante**. Regulamentada pela **RDC ANVISA nº 503/2021** (que substituiu a RDC 63/2000).

Cuidados de enfermagem na NE:

- Confirmar o posicionamento da sonda antes de iniciar a dieta (radiografia, na sonda nasoenteral).
- Manter a **cabeceira elevada entre 30° e 45°** durante a infusão e por **30 a 60 minutos após** (prevenção de broncoaspiração).
- Conferir rótulo: nome do paciente, composição, volume, velocidade, data e hora de preparo e validade.
- Administração **intermitente** (gravitacional ou em bolus com seringa) ou **contínua** (bomba de infusão).
- **Lavar a sonda com 20 a 30 mL de água** filtrada (em adultos) antes e depois de cada dieta e de cada medicamento, para evitar obstrução.
- Não misturar medicamentos com a dieta; triturar apenas comprimidos que podem ser triturados (não triturar revestidos, de liberação prolongada ou sublinguais) e administrar cada um separadamente.
- Dieta em sistema aberto (frasco manipulado): tempo máximo de infusão de cerca de **4 horas** em temperatura ambiente; sistema fechado: até **24 horas** (conforme o fabricante).
- Observar complicações: **diarreia** (a mais comum), distensão abdominal, vômitos, resíduo gástrico elevado, broncoaspiração, deslocamento ou obstrução da sonda.
- Registrar volume infundido e aceitação.

Nutrição parenteral (NP): administração de nutrientes por **via endovenosa** (central ou periférica), quando o trato gastrintestinal **não pode ser usado** ou é insuficiente. Regulamentada pela Portaria SVS/MS nº 272/1998. Cuidados: via **exclusiva** do cateter para a NP (não administrar medicamentos nem coletar sangue pela mesma via), uso obrigatório de **bomba de infusão**, **técnica asséptica rigorosa**, troca da bolsa e do equipo a cada **24 horas**, conservação sob refrigeração (2 °C a 8 °C) até o uso e retirada da geladeira cerca de 1 hora antes, proteção da luz quando houver vitaminas,

controle de glicemia capilar (risco de hiperglicemia; a suspensão abrupta pode causar hipoglicemia), balanço hídrico e peso diário. Nunca acelerar a infusão para compensar atraso.

16.5 Avaliação nutricional

Medidas antropométricas: peso, altura, **IMC** (ver Assunto 9), circunferência abdominal, circunferência da panturrilha (idosos – < 31 cm indica perda de massa muscular), pregas cutâneas. No **idoso**, considera-se eutrofia o IMC entre **22 e 27 kg/m²** (critério de Lipschitz), baixo peso < 22 e sobrepeso > 27. Na criança, usam-se as curvas da OMS da Caderneta da Criança (peso/idade, estatura/idade, IMC/idade).

Desnutrição energético-proteica: marasmo (déficit calórico global – emagrecimento intenso, "aspecto de velho") e kwashiorkor (déficit predominantemente proteico – **edema**, alterações de cabelo e pele, hepatomegalia).

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Calorias: carboidrato 4, proteína 4, lipídio 9 kcal/g.
- Vitaminas lipossolúveis A, D, E, K; deficiências clássicas (escorbuto, raquitismo, cegueira noturna).
- Anemia ferropriva; ferro e vitamina C.
- Guia Alimentar: base de alimentos in natura; evitar ultraprocessados.
- Consistências das dietas hospitalares; dieta líquida restrita como primeira após cirurgia.
- NE: cabeceira 30–45°, lavagem da sonda com água, diarreia como complicação mais comum.
- NP: via exclusiva, bomba de infusão, troca a cada 24 h, controle glicêmico.
- IMC do idoso (22–27).

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"4-4-9"**: carboidrato, proteína, gordura.
- **"ADEK se dissolve em gordura"**.
- **"Escorbuto sangra a gengiva por falta de C"**.
- **"Intestino funciona? Use-o"**: enteral antes da parenteral.
- **"Parenteral tem via só dela"**.
- **"Kwashiorkor incha, marasmo seca"**.
- **"Idoso: 22 a 27 está bom"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Durante a administração de dieta enteral por sonda nasoenteral, constitui cuidado de enfermagem correto:

(A) manter o paciente em decúbito dorsal horizontal durante a infusão.
(B) manter a cabeceira elevada entre 30° e 45° durante a infusão e após o término, lavando a sonda com água antes e depois da dieta.
(C) misturar todos os medicamentos triturados ao frasco da dieta.
(D) iniciar a dieta antes da confirmação radiológica do posicionamento da sonda.
(E) acelerar a infusão para compensar atrasos.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o decúbito zero aumenta o risco de broncoaspiração.

B) Correta – a elevação da cabeceira previne broncoaspiração e a lavagem evita obstrução da sonda.

C) Incorreta – medicamentos não devem ser misturados à dieta, pelo risco de interação e obstrução.

D) Incorreta – a posição da sonda nasoenteral deve ser confirmada por radiografia.

E) Incorreta – infusão rápida causa diarreia, distensão e vômitos.

QUESTÃO 02

Em relação à nutrição parenteral, é correto afirmar:

(A) pode ser infundida pela mesma via usada para medicamentos e coleta de sangue.
(B) dispensa o uso de bomba de infusão.
(C) deve ser infundida por via exclusiva, com bomba de infusão, técnica asséptica rigorosa e controle da glicemia capilar.
(D) é indicada para pacientes com trato gastrintestinal funcionante e sem restrições.
(E) a bolsa pode permanecer instalada por 72 horas.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a via deve ser exclusiva pelo alto risco de contaminação e incompatibilidade.

B) Incorreta – a bomba de infusão é obrigatória para controle preciso.

C) Correta – são os cuidados essenciais da NP.

D) Incorreta – se o TGI funciona, a via enteral é preferida.

E) Incorreta – a bolsa e o equipo são trocados a cada 24 horas.

QUESTÃO 03

A deficiência de vitamina C provoca:

(A) raquitismo.
(B) escorbuto.
(C) beribéri.
(D) cegueira noturna.
(E) bócio.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o raquitismo decorre da deficiência de vitamina D.

B) Correta – o escorbuto, com sangramento gengival e má cicatrização, decorre da falta de vitamina C.

C) Incorreta – o beribéri está ligado à deficiência de vitamina B1.

D) Incorreta – a cegueira noturna está ligada à deficiência de vitamina A.

E) Incorreta – o bócio está ligado à deficiência de iodo.

QUESTÃO 04

No pós-operatório imediato de cirurgia abdominal, após liberação médica para início da alimentação, a primeira dieta geralmente oferecida é a:

(A) geral.
(B) branda.
(C) pastosa.
(D) líquida restrita (de prova).
(E) hiperproteica sólida.

✔️ **GABARITO: D**

Comentário:

A) Incorreta – a dieta geral é oferecida após a progressão.

B) Incorreta – a branda é etapa posterior.

C) Incorreta – a pastosa vem depois das dietas líquidas.

D) Correta – a dieta líquida restrita (água, chás, caldos coados) testa a tolerância do trato gastrintestinal.

E) Incorreta – a consistência sólida não é a primeira etapa.

QUESTÃO 05

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, a base da alimentação deve ser composta por:

(A) alimentos ultraprocessados enriquecidos com vitaminas.
(B) alimentos in natura ou minimamente processados.
(C) alimentos processados e conservas.

(D) óleos, sal e açúcar em grandes quantidades.
(E) suplementos alimentares industrializados.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – os ultraprocessados devem ser evitados.

B) Correta – a regra de ouro do Guia é preferir alimentos in natura ou minimamente processados.

C) Incorreta – os processados devem ser limitados.

D) Incorreta – os ingredientes culinários devem ser usados em pequenas quantidades.

E) Incorreta – suplementos não são a base da alimentação saudável.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: macro e micronutrientes; deficiências vitamínicas e minerais; Guia Alimentar (2014); dietas hospitalares e especiais; nutrição enteral (RDC 503/2021) e parenteral; avaliação nutricional; desnutrição.

Quadro-resumo: 4-4-9 kcal/g; cabeceira 30–45° na NE; lavagem da sonda com 20–30 mL de água; NP – via exclusiva, troca a cada 24 h; IMC do idoso 22–27.

Pegadinhas: medicamentos misturados à dieta; NP pela mesma via de medicamentos; ultraprocessados enriquecidos como base da dieta.

Erros comuns: confundir vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis; esquecer a glicemia capilar na NP; usar IMC do adulto para idosos.